

31. DIAFRAGMA PRÁCTICO - 3 TÉCNICAS

DURACIÓN : 16:09

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo presenta dos técnicas de liberación del diafragma, esenciales para mejorar la función respiratoria y el estado general de los pacientes, especialmente los niños. La primera técnica se centra en la unión esofágica y diafragmática, utilizando movimientos espirales y la escucha tisular para liberar la presión a nivel del diafragma. El protocolo práctico detallado incluye pasos de evaluación de la nuca, relajación y movilización, con el objetivo de restaurar la libertad de movimiento. La segunda técnica se dirige a la cavidad posterior de los epiplones y las inserciones esofágicas, destacando la importancia de la interacción entre las costillas y el diafragma. Estos enfoques, arraigados en la práctica biodinámica, buscan el bienestar global del paciente.

DIAFRAGMA PRÁCTICO - 3 TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DIAFRAGMÁTICAS

Vamos a explorar dos técnicas principales. La primera es un enfoque **mecánico** para liberar el espacio diafragmático. La segunda es un enfoque **global** del diafragma, particularmente eficaz en niños y bebés, para devolver una **expansión óptima**. Esta técnica se inscribe en una práctica de tipo **biodinámico**.

TÉCNICA 1: LIBERACIÓN DE LA UNIÓN ESOFÁGICA Y DIAFRAGMÁTICA

Trabajaremos específicamente en la **encrucijada** entre el esófago y el diafragma. Esta región es rica en **redes nerviosas**, especialmente con el tronco del **nervio vago**. El objetivo es liberar esta zona suavemente, lo que tendrá el efecto de descargar toda la zona vagal circundante.

ANATOMÍA CLAVE

- Observaremos la porción diafragmática derecha e izquierda.
- La **pleura** también está presente aquí.
- Hay un vestigio anatómico, antiguamente una vena, llamada la **vena de Treitz y Lehmer**.
- Un pequeño músculo se inserta en el diafragma y el peritoneo, formando el espacio **periesofágico**. Este espacio tiene una función de adaptabilidad y reequilibrio en relación con

la unión diafragmática.

- Esta estructura se prolonga con el **músculo de Treitz**, que es el ligamento suspensorio del duodeno.

EL MOVIMIENTO ESPIRAL DEL CUERPO

El cuerpo a menudo está organizado en **espirales**, un movimiento potente que se encuentra en todas partes. El embrión mismo se desarrolla según movimientos espirales. Utilizamos las espirales en energética para apuntar a puntos precisos. Aquí, aplicaremos este principio de movimiento espiral.

PROTOCOLO PRÁCTICO

1. **Localización:** Posiciónese a nivel de la unión, donde pueda acceder a la parte más alta del estómago.

2. Test Preliminar del Cuello:

- Gire la cabeza hacia la izquierda y sienta la sensación.
- Vuelva al centro, luego gire la cabeza a la derecha.
- Vuelva al centro, luego gire la cabeza a la izquierda de nuevo. Observe si la rotación está limitada. Muy a menudo, esta zona diafragmática impide una buena rotación del cuello.

3. Posicionamiento y Relajación:

- Posiciónese y deje que la persona se eche hacia atrás hacia usted.
- Pídale que se relaje completamente. Sostenga a la persona.
- Mantenga un punto de apoyo con su pulgar.

4. Descenso y Escucha Tisular:

- Comience a descender suavemente, en profundidad. Busque los tejidos.
- Escuche los tejidos. Observe la respiración de la persona. En la exhalación, descienda y encuentre un ligero tope, una cierta densidad.

5. Estabilización y Movilización Progresiva:

- Posiciónese suavemente, tomando un buen punto de apoyo posterior, bien recto, para estar estable.
- Verifique que la persona no sienta dolor.
- Descienda aún más, dejando un pequeño margen debido a la ropa.
- Pida a la persona que se incorpore muy suavemente. Puede sentir el "hop" subir con usted.
- Repita el movimiento: subida suave, luego relajación. Gane terreno.

- A veces, sienta un "freno" y busque un poco más allá, subiendo y bajando de nuevo.

6. Toma Posterior y Sensación:

- Luego, tome la parte posterior entre sus dos manos.
- Pida a la persona que se relaje completamente. Verifique la ausencia de dolor excesivo.
- Una sensación puede sentirse, luego "se abre a nivel de la vesícula".

7. Verificación Post-Técnica:

- Busque un apoyo posterior y regrese.
- Pida a la persona que gire la cabeza hacia la izquierda de nuevo para verificar la movilidad.

TÉCNICA 2: LIBERACIÓN DE LA CAVIDAD POSTERIOR DE LOS EPIPLONES Y DEL ESTÓMAGO

Esta técnica se centra en la cavidad posterior de los epiplones y las inserciones esofágicas. No olvide la importancia de las **costillas** en relación con el diafragma, donde hay una concentración importante.

PROTOCOLO PRÁCTICO

1. **Localización:** Colóquese donde se hace el "agujero".
2. **Posicionamiento de la Mano:** Coloque su mano plana hacia la unión, a nivel de las costillas 7ª, 8ª, 9ª.
3. **Deslizamiento y Relajación:** Deslice su mano por debajo y apóyela plana. Luego, venga con la otra mano.
4. **Brazo de Palanca:** Relaje y cree un pequeño brazo de palanca. Esta zona es una encrucijada importante de tensiones.
5. **Efectos:**
 - Esto liberará toda la unión estómago-cardias.
 - Esto relajará la zona muscular de Treitz y las estructuras asociadas.
 - Esto actúa sobre esta relación vital.

SENSACIÓN GLOBAL Y BOLSA RETROGÁSTRICA

- Concéntrese en una sensación más global. Toque todo el cuerpo.
- La **bolsa retrogástrica** es muy importante de movilizar. Las úlceras suelen ser posteriores y esta bolsa necesita movilidad para un buen peristaltismo y una buena función. Debe estar libre.
- Si no está bien libre, no está liberada en relación con el diafragma.

ENLACES ANATÓMICOS ESENCIALES

- El esófago y el estómago son los primeros órganos en relación con la base del cráneo.
- Tienen una relación con el **mesogastrio posterior**, el cuerno y los bronquios principales izquierdos. Puede sentir el calor subir, luego bajar.

ENFOQUE BIODINÁMICO Y DESARROLLO EMBRIONARIO

Ahora exploro otro nivel: la fuerza del **desarrollo embrionario**, el apoyo, la potencia. Observo la respiración y percibo un trabajo fascial que busca dar más espacio entre el diafragma y la zona pulmonar posterior.

EL PLANO PERITONEAL

- En el plano peritoneal, el **ángulo cólico izquierdo** es el primer punto fijo del desarrollo global del peritoneo. Es el primer punto de apoyo.
- Concéntrese en este punto de apoyo, luego en el punto de movilidad.
- El punto más móvil es el **ciego**, el último en establecerse. Evalúe cómo está.
- Entre sus dos manos, tiene todo el eje de rotación del marco cólico. El diafragma trabaja sobre estas estructuras.
- En este espacio, tiene todos los ligamentos, como el **ligamento falciforme**.

ELECCIÓN TERAPÉUTICA

El practicante puede elegir en qué trabajar, pero a menudo el cuerpo del paciente guía esta elección.

- Por ejemplo, una tensión en el ligamento falciforme, o en su hoja.
- A veces, hay la expresión de una "gentil ira", como si faltara un punto de apoyo posterior, o que hubiera necesidad de una liberación aquí.
- Este trabajo se realiza en sincronidad con la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro, a nivel de la **crista galli**. Se trabajará sobre el seno.

EXPRESIÓN DE LA IRA EN BIODINÁMICA

La ira puede expresarse como una incapacidad en un momento dado para expresarse. Esto puede datar de mucho tiempo, relacionado con lo que no se pudo decir. En biodinámica, abordo el protocolo poniéndome en la globalidad. Dejo la respiración torácica y entro en el espacio, dejándolo abierto. El cuerpo me guía entonces hacia puntos de apoyo. Pueden aparecer "flashes", indicando una tensión.

LA CLAVE DEL ENFOQUE BIODINÁMICO (INICIÁTICO)

- Sumérgase en el agua (metafóricamente).

- Escuche el movimiento.
- Sienta el movimiento.
- Busque el **balance** (el punto de equilibrio).
- Una vez que haya encontrado el punto de balance, escuche el silencio detrás.

Cuando las células "responden" y se abren a la recepción, es un **"encendido" celular**.

PRECAUCIONES Y POSICIONAMIENTO DE LAS MANOS

Cuando se aborda el diafragma, se trata de dar espacio al diafragma.

ERRORES A EVITAR

- **Presionar la cabeza:** Debe haber una sensación equitativa entre las manos. Un error importante es presionar la cabeza de la persona, lo cual es muy desagradable a la larga.
- **Mala postura:** Tenga un buen apoyo en sus codos.

CONSEJOS DE POSICIONAMIENTO

Imagine que come ajo y que toma el espacio correcto. Es crucial encontrar el espacio correcto.

GUÍA MEDITATIVA Y ESTADO DEL TERAPEUTA

En esta práctica, le guiaré en un estado **meditativo**.

- Posiciónese justo en la posición correcta.
- Como receptor, intente definir su percepción de la posición.

SENSACIÓN DE TACTO

El tacto es muy ligero, con mucho calor. Es global, se tiene la impresión de que se extiende hasta los pies. Al mismo tiempo, existe esta sensación de que capto el **"campo microcristalino"**: todas estas células, esta pequeña red celular con sus receptores. Es un campo enorme.

EL CAMPO DE GLICOCÁLIX

El mayor lugar de concentración de información de un campo de **glicocáliz** se encuentra a nivel del **segundo duodeno**, la parte más informada del intestino. Este campo está presente en todo el cuerpo, como un campo global que lo abarca todo. Esto permite establecer un contacto profundo.